

Object : Sujet de votre organisation pour les projets « *Policy-in-Action* » 2025-2026

Cher Partenaire,

Afin de préparer l'année académique 2024-2025, pourriez-vous nous indiquer d'ici au **15 septembre 2025** un (ou plusieurs) sujet(s) de « *Policy-in-Action* » que vous souhaiteriez proposer à nos étudiants. Le format attendu est indiqué ci-dessous.

Pour rappel, un projet « *Policy-in-Action* » consiste à proposer à nos étudiants un sujet et/ou une problématique que vos équipes se posent. Chaque projet sera traité par un groupe de 3 à 5 étudiants et sera **encadré par nos soins**. Le suivi des projets se fera au fil de l'eau et nous n'attendons de votre part qu'une participation aux points d'étape typiquement : une première réunion de lancement et de cadrage (1h), une réunion de suivi où les étudiants pourront vous montrer les résultats intermédiaires et vous interrogez sur les problèmes rencontrés (1h), une réunion terminale où vous serez présentés les résultats (1h). Au terme de ce travail, les programmes et les analyses effectuées durant le projet seront mis à votre disposition, et le cas échéant valorisés sur un GitHub et déployés sur Onyxia.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

Octobre 2025 :	Réunion de lancement et de cadrage
Décembre 2025 / Janvier 2026 :	Réunion intermédiaire
Mars 2026 / Avril 2026 :	Réunion terminal de restitution

Nous attendons avec impatience vos propositions, qui nous l'espérons seront nombreuses, et nous restons à votre disposition si vous avez des questions ou pour un retour sur vos sujets.

Bien cordialement,

Les directeurs du programme, Franck Malherbet et Pierre Boyer



Proposition de **Policy-in-Action Project** : année 2025-2026

(Retour souhaité avant le 15/09/2025)

Sujet / Titre : Manques de personnel médical dans les services d'urgences et fermetures inopinées

Présentation du sujet proposé aux étudiants (un paragraphe) :

La problématique d'un **manque de médecins urgentistes** reste prégnante en 2025 alors que **le nombre de médecins aux urgences est plus élevé qu'il y a dix ans, même en le rapportant au nombre de passages aux urgences** : en dix ans, le nombre de passage aux urgences a crû de 9,1 % (de 19,6 millions en 2014 à 21,3 millions en 2024) alors que le nombre de postes de médecins y a crû de près de 20 % (de 5300 équivalent temps plein annuels [ETP] en 2014 à 6500 ETP déclarés en 2021, puis de 6100 ETP annuels moyens des seuls salariés en 2022 à 6000 ETP de salariés en 2024). **Est-ce simplement que ces ressources médicales sont inégalement réparties ?** Le travail consistera à **déterminer et caractériser les services où le ratio de médecins par passages (ou le nombre de médecins) est insuffisant** ; et plus fondamentalement de **décrire et caractériser l'importance du manque de médecins urgentistes dans les fermetures partielles ou complètes des services d'urgences** (sachant qu'une partie du travail sera justement d'**établir une base exhaustive de ces fermetures**, par l'identification des sources appropriées ou à l'aide de modèles LLM).

A titre purement complémentaire, le même type d'analyses pourrait être également effectué sur les maternités, et le ratio de naissances par effectifs d'obstétriciens, ou de sage-femmes, ainsi que les fermetures temporaires ou définitives de maternités.

Problématique et enjeux techniques (quelques paragraphes) :

Les étudiants pourront en premier lieu s'appuyer sur le **bordereau Urgences de la Statistique Annuelle des Etablissements de santé** (SAE, enquête annuelle exhaustive sur les établissements de santé en France), pour **déterminer et caractériser les services où le ratio de médecins par passages (ou le nombre de médecins) est insuffisant**. Les données de passages aux urgences de ces bordereaux étant très contrôlés, mais un peu moins celles concernant les personnels concourant à l'activité (PCA) des services d'urgence, ce sera déjà l'occasion d'**analyser de façon critiques des données d'enquête (voir de proposer des redressements statistiques dans les cas les plus avérés)**. Ce sera aussi l'occasion d'un **travail statistique descriptif en coupes (2024 ; 2014) pour comprendre où il y a peu de personnel médical** (en valeur absolue, ou relativement au nombre de passage) et de **l'analyser suivant différentes dimensions** (secteur juridique, type de département ou d'aire urbaine, urgences générales/adulte/pédiatrique, taille du service en nombre de passages, etc.), **ou en panels** (dans quels endroits la situation s'est détériorée en dix ans, et comment se caractérisent-ils ?).

L'enquête Urgences pourra être utilisée dès ce moment puisqu'elle offre une caractérisation fine des services en 2013 et en 2023, avec en 2023 la situation sur un jour donné dans l'année (et suivant trois créneaux horaires pour le personnel), pouvant offrir un contrepoint à la situation sur une année présentée par la SAE.

Une part complémentaire du travail des étudiants consistera alors à **établir de façon automatisée une base des fermetures partielles des services d'urgences et de leurs modalités** (suivant quelles périodes, les horaires de fermeture) **et de mise en place de régulation préalable** (suivant quelles périodes, à quels horaires) **depuis au moins 2023**. Ils pourront pour cela consulter le **site des Agences régionales de santé** (par exemple [ici](#) pour la Bretagne en 2024/2025) ou les contacter, et **mettront surtout un recueil de données structurée via appel à un modèle de LLM (avec requête Internet) pour l'établir** (voir [ici](#) un exemple – sans structuration de la réponse et sans automatisation – de demande LLM avec requête Internet montrant que c'est possible dans ce contexte). L'exhaustivité et le taux d'erreur de ce recueil pourra être confronté à plusieurs sources : les recueils auprès des ARS d'une part ; l'enquête Urgences 2023, volet structure, pour la période précédent juin 2023 d'autre part ; les données journalières des RPU par structures d'autre part, pour lesquelles une convention permettra un accès confidentiel aux étudiants. En approfondissement éventuel, ce recueil pourrait aussi contenir la raison évoquée pour la fermeture, une référence, et, au-delà des fermetures, les risques signalés de fermeture des structures des urgences.

Une fois cette base établie, et rendue crédible par recoupement, les étudiants chercheront à établir si les établissements avec de telles fermetures ou de régulations recoupent les établissements avec peu de personnels médicaux identifiés en première partie ; si ce n'est pas le cas, il sera intéressant de déterminer les autres facteurs de risque (le secteur juridique ? la distance au service d'urgences le plus proche ? etc ?). Un descriptif statistique des fermetures et régulations, avec un angle régional et en évolutions, sera aussi très intéressant (voir notamment Khaoua, avec Suarez Castillo [2024]).

Bibliographie ou références indicatives notamment :

Vous pouvez indiquer ce qui a éventuellement été déjà fait par vos équipes, la documentation recommandée et les suggestions de lecture académiques et/ou institutionnelles. Les étudiants n'étant pas nécessairement francophones, merci de choisir de préférences des sources en anglais.

- [La Statistique annuelle des établissements de santé \(SAE\) | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques](#)
- [Enquête Urgences 2023 | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques](#)
 - o Demoly E., Deroyon T. (2025, mars). [Urgences : la moitié des patients y restent plus de 3 heures en 2023, 45 minutes de plus qu'en 2013](#). DREES, *Études et Résultats*, 1334.
 - o Demoly E., Bara W., Naouri D., Boisguerin B., Bianchi C. (2024, juillet). [Urgences hospitalières en 2023 : quelles organisations pour la prise en charge des patients ?](#). DREES, *Études et Résultats*, 1305.
- Khaoua H., avec la collaboration de Suarez Castillo M. (2024, décembre). [Passages aux urgences entre 2017 et 2023 : des dynamiques contrastées selon les départements](#). DREES, *Études et Résultats*, 1320.

La solution visée :

Voir supra.

Données mises à disposition ou disponibles en open data :¹

Les Policy-in-Action Project sont des projets appliqués. Il est important de penser, autant que possible, en amont l'accès aux données. Les étudiants DEPP sont par défaut enrôlés au CASD, si votre projet nécessite un accès CASD merci de nous l'indiquer. Il est également possible de mettre à disposition les données sur [Onyxia Datalab](#) et d'établir une convention cadre.

SAE (en open data)

Enquête urgences (volet structure en open data ; mise à disposition du volet RH pas encore en open data).

RPU données journalières par structure (en adaptant la convention de l'année dernière à ce sujet).

Software / Solutions logicielles :

Pour faciliter l'appropriation et l'utilisation par vos équipes des solutions proposées dans le cadre du projet, vous pouvez, le cas échéant indiquer vos préférences pour les solutions logicielles utilisées. Nos étudiants ont tous des compétences en R, Python, Stata.

Très forte préférence pour R. Nous comprenons si Python est utilisé pour les interactions avec les LLM.

Qui seront les utilisateurs des résultats du projet, de l'outil développé ?

Les résultats et statistiques intéresseront fortement le Bureau Etablissements de Santé (BES).

Le recueil des fermetures et régulation sera développé dans une perspective rétrospective (pas utile de regarder 2025 à ce stade) ; un développement ultérieur pourrait être de le modifier pour en faire un outil de suivi en temps réel, auquel cas il pourrait probablement intéresser des collègues de la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) en charge de ces sujets.

Envisagez-vous de proposer un stage de fin d'année dans la continuité de ce projet ?

Pour rappel, les étudiants de DEPP doivent faire un stage long de minimum 16 semaines à la fin du M1 et de minimum 20 semaines à la fin du M2. Les stages couvrent généralement la période de début avril à fin août.

Suivant les résultats du projet (et les crédits pour des stages disponibles), un stage pourrait être envisagé pour approfondir l'un des sujets et en réaliser un Etudes & Résultats.

Avez-vous des remarques additionnelles ?

Noms et coordonnées des personnes de votre organisation impliquées dans le cadre de ce projet :

Référent 1 :

Nom : Cazenave-Lacrouz

Prénom : Alexandre

Courriel : alexandre.cazenave-lacroutz@sante.gouv.fr

Téléphone : +33699372540

¹ Dans le cadre des projets « Policy-in-Action », les données confidentielles ou non pourront être traitées sur la plateforme Onyxia (<https://www.onyxia.sh/>) de l'ENSAE. Seuls les étudiants dûment habilités à travailler sur le projet seront en mesure d'accéder aux données.

Référent 2 :

Nom : Prénom :

Courriel :

Téléphone :

Commenté [AC1]: Cela sera peut-être enrichi si le sujet est retenu par des étudiants.

